¿Añadir tirzepatida a ixekizumab controla mejor la artritis psoriásica con obesidad, o solo suma la pérdida de peso?

Merola JF, Kartman CE, Fischer P, Mease P, Kivitz A, Sattar N, Coates LC, Aletaha D, Sun L, Chen Y, Marulkar K, Bello N, Cardoso A, Genovese MC, Ogdie A. Durable and additive disease control at 52 weeks with ixekizumab plus tirzepatide versus ixekizumab alone in adults with psoriatic arthritis and obesity or overweight: additional results from a randomized clinical trial. *Arthritis Rheumatol*. 2026 [publicado en línea el 11 nov 2026]. doi:10.1002/art.70375

Versión 1.0 · Revisado el 12 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

PREGUNTA

¿Sumar tirzepatida a ixekizumab mejora la APs a un año?

En adultos con artritis psoriásica (APs) activa y obesidad, o sobrepeso con comorbilidad: actividad, peso y seguridad a 52 semanas.

RESPUESTA

Más respuesta, datos exploratorios

ACR50 43.7 frente a 15.7 %, MDA 28.2 frente a 13.6 % y peso −20.4 frente a −0.6 %. Ensayo abierto, sin grupo de tirzepatida sola, patrocinado por el fabricante de ambos fármacos.

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

Refuerza y matiza

Refuerza tratar la obesidad como parte de la APs. No demuestra un efecto antiinflamatorio propio de la tirzepatida ni que se repita con otros biológicos.

En 30 segundos. TOGETHER-PsA es un ensayo fase 3b **abierto, con evaluador cegado**, en EUA: 271 adultos con APs activa e IMC ≥30 (o 27 a <30 con comorbilidad) se aleatorizaron a **ixekizumab (IXE) + tirzepatida (TZP)** o a **IXE solo**, sin placebo. El desenlace primario, ya publicado a la semana 36, fue un **compuesto: ACR50 y pérdida de peso ≥10 % al mismo tiempo**. Este reporte es de la semana 52, con análisis **exploratorios y p nominales**: compuesto 39.2 frente a 1.7 % (diferencia 37.5 puntos), **ACR50 43.7 frente a 15.7 %** (28.0 puntos), MDA 28.2 frente a 13.6 % y peso −20.4 frente a −0.6 %. Más náusea (29.7 frente a 3.0 %) y otros síntomas digestivos con la combinación; eventos graves 4.3 frente a 8.3 %. La clave: el compuesto está dominado por el peso, que el grupo control casi no podía lograr.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Desenlaces compuestos que mezclan dos efectos: cómo descomponer «ACR50 + pérdida de peso ≥10 %», por qué un comparador que no puede lograr uno de los componentes infla la diferencia, y qué cambia con un diseño abierto y un análisis exploratorio.

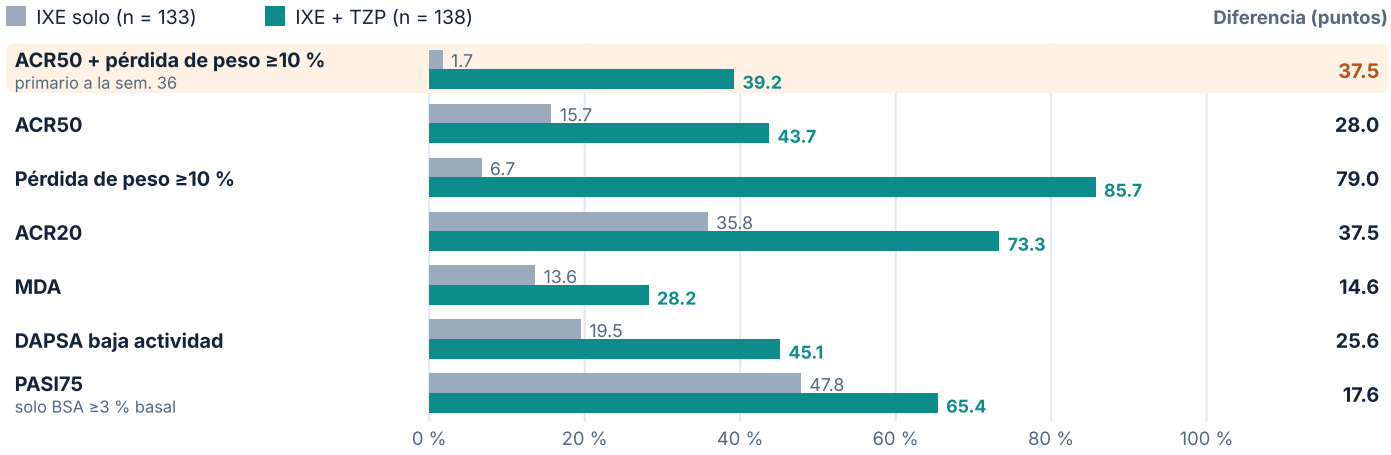
1 Diseño y población (PICO)

P · POBLACIÓN	Adultos de 18 a 80 años con APs activa (≥3/68 articulaciones dolorosas y ≥3/66 inflamadas, ≥6 meses, criterios CASPAR) y obesidad (IMC ≥30) o sobrepeso (IMC 27 a <30) con ≥1 comorbilidad: HTA, dislipidemia, apnea del sueño, enfermedad cardiovascular o DM2. Excluidos: falla a >3 clases de terapia avanzada, uso previo de IXE o TZP, falla o intolerancia a un inhibidor de IL-17 o a un arGLP-1.
I · INTERVENCIÓN	IXE + TZP a dosis aprobadas por la FDA. IXE 160 mg SC en la semana 0 y luego 80 mg cada 4 semanas (o esquema de psoriasis si era moderada a grave). TZP SC semanal desde 2.5 mg, con aumentos de 2.5 mg cada 4 semanas hasta 15 mg (dosis máxima tolerada) en la semana 20; desde la semana 32 se permitía mantener 5, 10 o 15 mg.
C · COMPARADOR	IXE solo, **sin placebo**. Ambos grupos con consejería de dieta y ejercicio; tratamiento de base permitido, sin agregar ni cambiar biológicos.
O · DESENLACES	**Primario (semana 36, con control de multiplicidad):** ACR50 y pérdida de peso ≥10 % a la vez. **Secundarios clave (semana 36):** ACR50; ACR20 + pérdida ≥5 %; pérdida ≥10 %. **Semana 52 (este reporte):** preespecificados, exploratorios, sin control de multiplicidad.
DISEÑO	Fase 3b, multicéntrico (EUA y Puerto Rico), **abierto**, 52 semanas (NCT06588296); aleatorización 1:1 estratificada por sexo, terapia avanzada previa e IMC. **Evaluador cegado** para conteos articulares, entesitis (LEI), dactilitis y PASI.
PACIENTES	279 aleatorizados; 8 excluidos por no tener comorbilidad relacionada con el peso: 271 (138 IXE + TZP, 133 IXE). Basal: 69.7 % mujeres, 55.0 años, 106.1 kg, IMC 37.6, 26.7 articulaciones dolorosas y 12.3 inflamadas, 8.9 años de evolución; 63.1 % con terapia avanzada previa, 18.8 % con falla a ≥2 clases.
ANÁLISIS	Intención de tratar modificada. **Estimando hipotético**: efecto si todos hubieran seguido el tratamiento asignado; los datos posteriores a la suspensión o a medicación prohibida se excluyeron; en peso, ACR, MDA y DAPSA se usó imputación múltiple por grupo, y en otros desenlaces continuos, MMRM o ANCOVA con última observación arrastrada.

FINANCIAMIENTO	Eli Lilly, fabricante de ambos fármacos, participó en diseño, recolección, análisis, interpretación, redacción (redactor médico de la empresa) y decisión de publicar; 8 de 15 autores son empleados de Lilly. Los autores declaran que publicar no dependía de su aprobación.

2 Resultados principales a 52 semanas

Semana 52: proporción de pacientes que respondió (%)



Ojo: en el grupo IXE solo, apenas 6.7 % perdió ≥10 % de peso; por eso casi nadie podía cumplir el compuesto (1.7 %), aunque 15.7 % logró ACR50.

Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la tabla 1 del artículo (estimando hipotético, p nominales). No reproduce figuras originales.

DESENLACE (SEMANA 52)	IXE	IXE + TZP	DIFERENCIA (IC 95 %)	P
ACR50 + pérdida ≥10 % (compuesto)	1.7 %	39.2 %	**37.5 (28.5 a 46.5)**	<0.001
ACR50	15.7 %	43.7 %	**28.0 (17.1 a 38.9)**	<0.001
ACR20 · ACR70	35.8 · 8.3 %	73.3 · 15.7 %	37.5 (25.4 a 49.5) · 7.4 (−0.2 a 15.1)	<0.001 · 0.057
MDA	13.6 %	28.2 %	14.6 (5.1 a 24.0)	0.003
DAPSA: cambio · baja actividad	−20.3 · 19.5 %	−32.2 · 45.1 %	−11.9 (−15.9 a −7.9) · 25.6 (14.6 a 36.6)	<0.001
Articulaciones inflamadas (cegado)	−5.9	−9.7	−3.9 (−5.4 a −2.3)	<0.001
Entesitis (LEI) · sin dactilitis*	−0.7 · 56.5 %	−1.5 · 70.2 %	−0.8 (−1.4 a −0.2) · 13.7 (−8.0 a 35.5)	0.007 · 0.217
PASI75†	47.8 %	65.4 %	17.6 (1.0 a 34.2)	0.038
Dolor (EVA) · HAQ-DI	−14.4 · −0.3	−25.8 · −0.6	−11.4 (−17.2 a −5.6) · −0.3 (−0.4 a −0.1)	<0.001
PCR-us (mg/L) · FACIT-F	−0.4 · +4.8	−2.2 · +9.7	−1.8 (−2.6 a −1.0) · 4.9 (2.5 a 7.3)	<0.001
Peso: cambio · pérdida ≥10 %	−0.6 % · 6.7 %	−20.4 % · 85.7 %	−19.8 (−21.9 a −17.6) · 79.0 (70.2 a 87.7)	<0.001
HbA1c · triglicéridos · PAS	+0.2 % · +2.9 · −0.6	−0.6 % · −44.8 · −8.4	−0.7 % · −47.6 mg/dL · −7.8 mm Hg	<0.001

Cambios desde el inicio, salvo porcentajes de respondedores. Todas las p de la semana 52 son nominales. *Solo con dactilitis al inicio (33 y 42 pacientes). †Solo con ≥3 % de superficie corporal afectada (75 y 76). Compuesto ACR20 + pérdida ≥5 %: 72.1 frente a 10.7 %. Evaluación global del médico: −4.1 frente a −3.4 (p = 0.010). PASI90 y PASI100 sin diferencia significativa. Sin diferencia en LDL (p = 0.362) ni en PAD (p = 0.182). Dosis final de TZP: 15 mg en 65.2 %, 10 mg en 10.9 % y 5 mg en 13.0 % de quienes tenían el dato.

3 Cómo leer un desenlace compuesto que mezcla dos efectos

- **El compuesto premia lo que solo un grupo puede lograr.** DATO DEL ARTÍCULO Con IXE solo, 15.7 % alcanzó ACR50, pero apenas 6.7 % perdió ≥10 % de peso: compuesto 1.7 %. Con IXE + TZP, 43.7 % alcanzó ACR50 y 85.7 % perdió ≥10 %: compuesto 39.2 %. INTERPRETACIÓN Si los componentes fueran independientes, se esperaría 15.7 % × 6.7 % ≈ 1.1 % con IXE y 43.7 % × 85.7 % ≈ 37.5 % con la combinación, muy cerca de lo observado. En el control, el techo del compuesto lo pone el peso; con TZP, la artritis. Por eso la diferencia en el compuesto (37.5 puntos) supera la de ACR50 (28.0): al exigir además pérdida ≥10 %, el grupo control pierde casi todos sus respondedores ACR50 (de 15.7 a 1.7 %) y el de TZP pierde pocos (de 43.7 a 39.2 %). Era previsible al dar un fármaco contra la obesidad a un grupo y no al otro.
- **Separa los componentes.** INTERPRETACIÓN La pregunta articular se responde con ACR50, MDA, DAPSA y articulaciones inflamadas. Ahí la ventaja es clínicamente relevante: por cada ~4 pacientes con IXE + TZP en lugar de IXE solo, uno más alcanzaría ACR50 (1/0.280 = 3.6), y por cada ~7, uno más MDA (1/0.146 = 6.8); cálculos nuestros sobre datos exploratorios.

- **Abierto y sin placebo: no todos los componentes pesan igual.** DATO DEL ARTÍCULO Conteos articulares, entesitis y PASI los hizo un evaluador cegado; dolor, evaluación global del paciente, HAQ-DI y calidad de vida los reporta un paciente que sabe si recibe TZP, y los autores reconocen posible sesgo de expectativa. INTERPRETACIÓN ACR50 mezcla ambos tipos de medida y la PCR. La diferencia en articulaciones inflamadas (−3.9, cegada) da solidez; la evaluación global del médico, que no está entre las medidas cegadas, difirió menos que la del paciente en la misma escala (−0.7 frente a −1.6) y no aumentó su diferencia entre las semanas 36 y 52.
- **Adelgazar puede mover el ACR50 sin tocar la sinovitis.** DATO DEL ARTÍCULO La PCR-us bajó 2.2 frente a 0.4 mg/L; los autores lo plantean como posible efecto antiinflamatorio de TZP. INTERPRETACIÓN Perder 20 % del peso puede mejorar PCR, dolor y HAQ-DI (componentes del ACR) por menor inflamación sistémica y carga mecánica. Sin grupo de TZP sola no se separa un efecto antiinflamatorio propio del efecto del adelgazamiento.
- **La diferencia «creció» de la semana 36 a la 52.** DATO DEL ARTÍCULO En ACR50 pasó de 13.1 a 28.0 puntos; la respuesta con IXE fue numéricamente menor que en la semana 36. Suspendió el tratamiento 36.8 % con IXE (retiro voluntario 13.5 %; más casos por falta de eficacia) frente a 20.3 % con la combinación. La mayoría de esas suspensiones ocurrió antes de la semana 36 (después, 5 con IXE y 7 con la combinación); los autores consideran pequeño el descenso con IXE y señalan que los IC se superponen. INTERPRETACIÓN Con abandono desigual en un ensayo abierto y un estimando hipotético que imputa los datos faltantes, la semana 52 depende más de la imputación en el grupo control. Coherente, pero exploratorio.

4 Seguridad (52 semanas más 4 de seguimiento)

EVENTO	IXE (N = 132)	IXE + TZP (N = 138)
Cualquier evento adverso · grave	72 % · 8.3 %	79 % · 4.3 %
Náusea · diarrea · estreñimiento · vómito	3.0 · 5.3 · 3.0 · 0.8 %	29.7 · 18.8 · 16.7 · 10.9 %
Reacción en el sitio de inyección · infecciones	16.7 · 39.4 %	15.9 · 38.4 %
Suspensión por evento adverso · por evento digestivo	5.3 · 0.8 %	6.5 · 3.6 %
Pancreatitis · neoplasias	0 · 0	1 grave, atribuida al tratamiento · 2 no atribuidas (adenocarcinoma de páncreas en el mismo paciente y melanoma in situ)
Hipoglucemia en DM2 · grave · muertes	0 · 0 · 0	2 (1.4 % del grupo) · 0 · 0
ALT, cambio desde el inicio (*post hoc*)	+5.6 %	−22.7 %

DATO DEL ARTÍCULO La mayoría de los eventos fueron leves a moderados; sin señales nuevas según los autores. INTERPRETACIÓN El costo es digestivo: por cada ~4 pacientes con la combinación, uno más tendrá náusea (1/0.267 = 3.7). Una pancreatitis grave en 138 pacientes es una advertencia, no una tasa.

5 Fortalezas y limitaciones

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Aleatorización y evaluador cegado	Estratificada; conteos articulares, entesitis, dactilitis y PASI cegados.	Confirmado
● Población difícil	IMC 37.6, 69.7 % mujeres, 18.8 % con falla a ≥2 clases.	Declarado por los autores
● Abierto, sin placebo	Elegido para reflejar el uso real; posible sesgo de expectativa en lo que reporta el paciente.	Reconocido por los autores
● Semana 52 exploratoria	Sin control de multiplicidad; abandono 36.8 frente a 20.3 %, con imputación. Sin grupo de TZP sola (hay estudios en curso).	Reconocido por los autores
● Aplicabilidad	Solo EUA; IMC ≥27; sin falla previa a IL-17 ni arGLP-1; un solo biológico; 52 semanas.	Parcialmente reconocido (EUA, IMC, 52 semanas); resto, interpretación editorial
● Patrocinio	Lilly fabrica ambos fármacos y participó en todas las fases. No invalida el ensayo, pero conviene apoyarse en las medidas cegadas; sin grupo de TZP sola, «aditivo» describe la combinación frente a IXE.	Interpretación editorial

6 Cómo encaja con la evidencia previa y las guías

DATO DEL ARTÍCULO La obesidad o el sobrepeso afectan a 72 a 82 % de las personas con APs y se asocian a más actividad y peor respuesta a biológicos; en estudios previos, perder peso mejoró la actividad. TOGETHER-PsA (semana 36) y TOGETHER-PsO (psoriasis con obesidad) ya habían mostrado superioridad de la combinación. Las guías citadas (ACR/NPF 2018, GRAPPA 2021, EULAR 2023) apoyan controlar el peso y las comorbilidades. INTERPRETACIÓN Son anteriores al ensayo y no contemplan esta combinación: el estudio respalda lo que ya recomendaban, sin crear una indicación nueva.

7 Qué hacer en la consulta

- INTERPRETACIÓN En APs activa con IMC ≥30 (o ≥27 con comorbilidad), **mide peso y comorbilidades y trata la obesidad**, con un fármaco aprobado si está indicado; este ensayo sugiere además mejor respuesta articular junto a IXE. Considera costo y acceso a dos inyectables.
- INTERPRETACIÓN **Evalúa los dos objetivos por separado**: el peso por un lado y la actividad con medidas objetivas (articulaciones inflamadas, DAPSA, MDA) por otro. Adelgazar no significa sinovitis controlada.
- INTERPRETACIÓN No cambies un biológico que funciona para copiar este esquema (datos solo con IXE). Advierte sobre síntomas digestivos y vigila pancreatitis e hipoglucemia en DM2.

Lección de lectura crítica

- Un componente casi exclusivo de un grupo (pérdida ≥10 %) infla el compuesto: 37.5 frente a 28.0 puntos en ACR50.
- Exploratorio + p nominales + abandono desigual + imputación = hipótesis reforzada, no confirmación.
- Descompón el compuesto y juzga cada parte por su cegamiento; sin grupo de TZP sola no se separa el fármaco del adelgazamiento.

Qué me llevo

- Añadir TZP a IXE en APs con obesidad casi triplicó ACR50 (43.7 frente a 15.7 %) y duplicó MDA (28.2 frente a 13.6 %) a 52 semanas, con 20 % menos de peso, a costa de náusea en 3 de cada 10.
- Tratar la obesidad es parte de tratar la APs; falta confirmar la combinación con otros diseños y biológicos.

Pregunta 1. Un residente dice: «La tirzepatida multiplicó por 20 la respuesta articular: 39.2 frente a 1.7 %». ¿Lectura correcta? a) Es correcta, porque el compuesto incluye ACR50. b) Son cifras del compuesto ACR50 + pérdida ≥10 %; en ACR50 solo, fue 43.7 frente a 15.7 %. c) El resultado no vale por ser abierto.
Respuesta: b. Con IXE solo casi nadie perdió ≥10 % de peso (6.7 %), así que casi nadie podía cumplir el compuesto aunque lograra ACR50 (15.7 %). La ventaja articular real fue de 28.0 puntos.

Pregunta 2. Mujer de 52 años con APs activa, IMC 34 e HTA, que iniciará IXE, pregunta si agregar tirzepatida. ¿Qué respalda mejor este ensayo? a) La combinación se asoció a más ACR50 y MDA a 52 semanas que IXE solo, en análisis exploratorios, con más efectos digestivos. b) La tirzepatida sola controlaría la APs. c) La combinación reduce eventos cardiovasculares.
Respuesta: a. No hubo grupo de TZP sola (b); se midieron factores de riesgo, no eventos cardiovasculares (c).

Pregunta 3. La diferencia en ACR50 pasó de 13.1 (semana 36) a 28.0 puntos (semana 52). ¿Lectura más prudente? a) Confirma que el beneficio de TZP crece con el tiempo. b) Es exploratoria, con p nominal; influyen un descenso numérico pequeño con IXE solo y una mayor proporción de datos imputados en ese grupo (abandono acumulado 36.8 frente a 20.3 %). c) Demuestra que IXE pierde eficacia al año.
Respuesta: b. Solo la semana 36 tenía control de multiplicidad. El abandono desigual y la imputación pesan más en el grupo control.

8 Referencias

1. Merola JF, Kartman CE, Fischer P, Mease P, Kivitz A, Sattar N, et al. Durable and additive disease control at 52 weeks with ixekizumab plus tirzepatide versus ixekizumab alone in adults with psoriatic arthritis and obesity or overweight: additional results from a randomized clinical trial. Arthritis Rheumatol. 2026 [publicado en línea el 11 nov 2026]. doi:10.1002/art.70375
2. Merola JF, Mease P, Kivitz A, et al. Ixekizumab with tirzepatide achieved greater disease control than ixekizumab alone in adults with psoriatic arthritis and overweight or obesity: results from a randomized clinical trial. Arthritis Rheumatol. 2026;78(10):2089–2101. doi:10.1002/art.70134
3. Lebwohl M, Blauvelt A, Kartman CE, et al. Ixekizumab with or without tirzepatide in adults with psoriasis and overweight or obesity: a phase 3b randomized clinical trial. JAMA Dermatol. 2026;162(7):709–719. doi:10.1001/jamadermatol.2026.1753
4. Klingberg E, Bilberg A, Björkman S, et al. Weight loss improves disease activity in patients with psoriatic arthritis and obesity: an interventional study. Arthritis Res Ther. 2019;21(1):17. doi:10.1186/s13075-019-1810-5
5. Singh JA, Guyatt G, Ogdie A, et al. Special article: 2018 American College of Rheumatology/National Psoriasis Foundation guideline for the treatment of psoriatic arthritis. Arthritis Rheumatol. 2019;71(1):5–32. doi:10.1002/art.40726
6. Coates LC, Soriano ER, Corp N, et al. Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (GRAPPA): updated treatment recommendations for psoriatic arthritis 2021. Nat Rev Rheumatol. 2022;18(8):465–479. doi:10.1038/s41584-022-00798-0
7. Gossec L, Kerschbaumer A, Ferreira RJO, et al. EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2023 update. Ann Rheum Dis. 2024;83(6):706–719. doi:10.1136/ard-2024-225531

SOBRE ESTE ARTÍCULO EXPLICADO

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de IA y verificado contra el texto completo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. Cálculos y gráfica propios, hechos con las cifras publicadas. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante. Más en **medicinaenresumen.com** · @medicina.en.resumen